

Sera.Phina Lab 03 實作案例包

精神健康診斷與 OT 臨床推理練習

本案例為教學用途之去識別化虛構案例。請勿把少量資料直接視為正式診斷，目標是練習 reasoning process。

案例 A | 大學生退縮與被暗示感

23 歲大學生，近三個月逐漸減少與同學互動，經常待在宿舍，學業進度中斷。最近表示同學會透過社群貼文暗示他，覺得大家在討論自己。家人表示他原本喜歡打籃球與參與社團，但近期幾乎停止。睡眠變少，白天精神不穩定。尚未確認是否有幻聽、情緒高昂或低落、物質使用、身體疾病或藥物影響。

學生任務

- 請先列出 Known facts，不要直接寫診斷。
- 請提出 1-3 個診斷或臨床假設。
- 每個假設至少列出一項支持資料與一項反證／不一致資訊。
- 請列出至少三項 Missing Information，並說明為什麼重要。
- 請從 OT 角度分析可能的 occupation、role、routine、environment 問題。
- 請提出一個你想優先回答的 clinical question，並選擇可能的 assessment / FOR。

Clinical Reasoning Map 空白版

欄位	學生填寫
Presenting problems	
Symptoms / signs	
Known facts	
Diagnostic hypotheses	
Evidence supporting	
Evidence against / inconsistent	
Differential diagnoses / alternatives	
Missing information	
Occupational problems	
Strengths / resources	
Volition	
Habituation	
Performance capacity	
Environment	

Clinical question	
Possible assessments	
Possible FOR / model	
Intervention hypotheses	
Outcome indicators	
Client priorities	
Questions for teacher	

教師帶領提醒

- 此案例可引發精神病性症狀、情緒疾患、物質／身體因素等鑑別討論，但不應在資料不足時直接定論。
- 可特別追問：睡眠減少是失眠、焦慮、躁期相關，或作息破壞？
- 可要求學生把「停止社團與籃球」轉化為 volition、habituation、social participation 與 role change 的討論。
- 可請學生區分個案本人困擾、家人困擾、學校功能損害與治療優先順序。

Version 1.0 • 2026-10-02